

PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

TORTICOLIS

- Signo clínico definido como rotación de la cabeza e inclinación lateral del cuello.
- Puede ser fija o flexible y acompañarse o no de dolor cervical.



ETIOLOGÍA

Congénita	• Tortícolis muscular congénita (TMC) " <i>fibromatosis colli</i> ": hematoma del músculo esternocleidomastoideo (ECM), malposición intrauterina...
	• Síndromes congénitos de la columna cervical (S. de Klippel-Feil, Arnold-Chiari...)
Traumática	• Contusión a nivel de la columna cervical (lesión muscular, ligamentosa, ósea, medular, subluxación).
	• Traumatismo craneoencefálico, fractura de clavícula, etc.
Inflamatoria/infecciosa:	• Síndrome de Grisel (subluxación atloaxoidea no traumática asociada a infección de vías respiratorias)
	• ORL: faringitis, linfadenitis, absceso retrofaríngeo, otitis, mastoiditis, neumonía lóbulo superior.
	• Musculoesquelética local: osteomielitis vertebral, espondilodiscitis.
Sistémica	• Artritis crónica idiopática, polimiositis....
Tumoral	• Tumores de fosa posterior, espinal o partes blandas.
Neurológicas	• Distonía medicamentosa, tortícolis paroxístico benigno, miastenia gravis, poliomyelitis, etc.
Ocular	• Parálisis del oblicuo superior, nistagmus congénito, ambliopía, estrabismo.
Miscelánea	• Reflujo gastroesofágico (síndrome de Sandifer), hipoacusia unilateral, calcificación de discos intervertebrales, trastorno conversivo, tortícolis postural benigno.

SIGNOS DE ALARMA

- Exploración neurológica anormal
- Signos de hipertensión intracraneal
- Síntomas constitucionales
- Impotencia funcional marcada
- Duración mayor de 7 días
- Disfagia, dificultad respiratoria.

EXPLORACIÓN FÍSICA

INSPECCIÓN	Observar la actitud del cuello y la cabeza (grado de inclinación y rotación, movilización activa, el niño puede incluso necesitar sujetarse la cabeza con las manos). La presencia de cuello corto con implantación baja del pelo puede indicar malformaciones óseas de la columna cervical.
RANGOS DE MOVIMIENTO	Movilidad activa y pasiva (no forzar movimientos dolorosos).
PALPACIÓN	Buscando puntos dolorosos óseos y musculares, tumoraciones, crepitación.
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA	Déficits neurológicos y/o motores.

MEDIDAS POSTURALES

- Colocar al niño en la cuna de tal forma que para atender a los estímulos (voces, luces) deba girar el cuello hacia el lado afecto.
- Cambiar regularmente la posición del niño evitando posturas incorrectas que empeoren la tortícolis.
- Cuando esté despierto y en supino, colocar una almohadilla o apoyo blando sobre el lado homolateral a la contractura para que eleve la cabeza en relación al entorno.
- Tratar de darle el pecho del lado contralateral de la madre para que la posición sea la correcta.
- Cuando le dé de mamar del lado homolateral, la madre deberá adelantar el pezón para que éste lo busque en corrección.

ESTIRAMIENTOS PASIVOS

- Deben hacerse con suavidad tratando que el niño esté lo más relajado posible.
- Realizarlos 4 veces al día como mínimo, 20 repeticiones de cada ejercicio.
- Consiste en movilizar el cuello en sentido contrario a la deformidad. Mejor realizarlos entre dos personas: una sujetará los hombros del niño y la otra movilizará la cabeza.

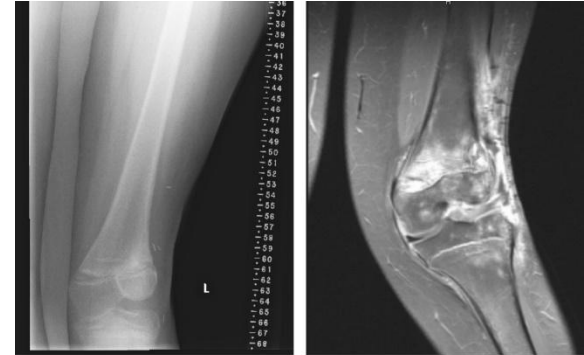
1. Inclinación de la cabeza hacia el lado contrario a la lesión.
2. Rotación de la cabeza llevando el mentón al lado opuesto.

Ejemplo: si la tortícolis es derecha (cuello inclinado hacia la derecha y mentón dirigido hacia la izquierda), se trata de llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y el mentón hacia el hombro derecho.



GENU VALGO

- Desalineación de fémur y tibia que provoca que una rodilla se desvíe hacia dentro y se junte con la otra. Si se produce en ambas rodillas vemos las típicas piernas en X con la cadera desplazada lateralmente, así como también los tobillos.
- Puede presentarse desde temprana edad hasta la edad adulta. En edades tempranas (3-5 años) suele ser habitual e incluso normal que los niños padezcan esta desviación, que debería corregirse durante los siguientes 2-3 años.
- Si transcurrido este periodo la desalineación persiste, será necesario acudir a un especialista para corregirla y evitar así que vaya a más.



GENU VARO

- Encontramos que una rodilla se separa de la otra. Si afecta a las dos rodillas observamos las piernas arqueadas en forma de paréntesis.
- Al igual que el genu valgo, esta desalineación también puede ser normal en edades tempranas y suele corregirse durante el proceso de crecimiento. Si eso no ocurre, debemos acudir a un especialista para corregirla y que no degenera en problemas mayores.





Genu Valgo



Genu Varo



Normal

CAUSAS

- **Postrauumática**
Al sufrir algún tipo de lesión que afecta a la estructura y que no se recupera correctamente.
- **Hereditaria**
Cuando existe una tendencia en algunos miembros de la familia a sufrir este tipo de alteraciones es habitual que sus descendientes puedan sufrir también éstos mismos problemas.
- **Mecánica**
Generado por desequilibrios o desajustes en la acción de caminar y/o correr
- **Estructural**
Cuando una pierna es más larga o corta que la otra

TRATAMIENTO

- Cuando la patología no es muy grave o no se encuentra en estado muy avanzado el uso de **plantillas correctivas** unido al trabajo de refuerzo y reequilibración muscular de la extremidad inferior y core, suele desactivar los mecanismos de lesión por sobrecarga y estrés, siendo parte fundamental en el tratamiento de estas patologías.
- En niños que todavía se encuentran en fase de crecimiento es posible corregir por completo las alteraciones mediante las plantillas, que deberán llevar hasta que se haya solucionado el problema.
- Por el contrario, si la patología se encuentra en estado muy avanzado y/o ha degenerado en artrosis de la articulación, la solución puede pasar por la intervención quirúrgica (osteotomía, prótesis).



TIBIAS VARAS

- Se han descrito dos formas clínicamente distintas de la enfermedad de Blount (aparición temprana y aparición tardía) basándose en si la deformidad del miembro inferior aparece antes o después de los cuatro años de edad.
- Estrecha asociación con la obesidad infantil indica una base mecánica.
- Se suele observar varo femoral distal en la forma de aparición tardía.
- Cuando un paciente presenta la enfermedad de aparición temprana, una osteotomía de realineación tibial antes de los cuatro años de edad reduce el riesgo de deformidad recurrente.
- La corrección gradual mediante osteogénesis por distracción es un medio eficaz para alcanzar una corrección multiplanar exacta, especialmente en pacientes con enfermedad de aparición tardía.







GENU RECURVATUM

- El genu recurvatum es una deformación de la rodilla relativamente caracterizada por un aumento del ángulo femoro-tibial en el plano sagital de más de 180° , o lo que es lo mismo, una hiperextensión de la rodilla más allá de 180° .
- Es anodino en niños sin otra patología articular, pero supone un grave problema para un niño con enfermedad neurológica u ortopédica.
- En los casos graves (mayor de 20°), se producen presiones excesivas sobre los cartílagos y las epífisis de crecimiento, con posible destrucción articular



El control ortopédico del genu recurvatum no es fácil:

- Se recurre a ejercicios de fortalecimiento isométrico de isquiotibiales y bíceps femoral.
- Uso de ortesis nocturna (KO: ortesis sueca), en los casos graves (neurológicos).
- También se adaptan KO o AFO durante el día.



Figura 5. A. *Genu recurvatum* grave en paciente con parálisis cerebral de tipo hemiparesia espástica izquierda. **B.** Corrección con ortesis tipo KO rígida.

CAUSAS

Si tomamos nuevamente las estructuras anatómicas, podemos deducir las causas principales:

- **Debilidad muscular:** músculos extensores de la pierna en el muslo: cuádriceps; músculos extensores de la cadera: músculos glúteos; músculos flexores de la rodilla: isquiotibiales.
- **Hipertonía espástica:** músculos extensores de la rodilla: cabeza derecha cuádriceps derecho; tríceps sural.
- **Limitación de la flexión dorsal del tobillo por espasticidad y / o retracción:** pie equino
- Anomalías óseas
- Traumatismos y/o fracturas
- Hiperlaxitud ligamentosa
- Retracciones tendinosas

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN